



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : ام هاشم عبد الله حفني عوض
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : حلوان
رقم البطاقة : 28006052101127 رقم التليفون : 01099116946
العنوان : البدرشين
العمر (تاريخ الميلاد) : 05-06-1980 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي زولاديكس تحت الجلد لمدة 6 شهور
قسم العلاج :
الأورام

[14163]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ام هاشم عبد الله حفني عوض National ID: 28006052101127	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Goserelin (Zoladex) subcutaneous

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

Patient Name : الأم هالة / أم هالة عبدالله حنفى	Request No. : 13003068
Patient Mo. : 28006052101127	Request Date : 09/03/2024
Path No. : 969/24	Verification Date : 24/03/2024
Sex : Female	Financial Category : دم - نفقة الدولة
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa moh

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Post NACT.

Source of the specimen: Left MRM, collected at 7/3/2024.

Gross Examination:

Procedure: Left MRM specimen measured 26x16x5 cm, covering skin ellipse measured 15x15 cm, nipple and areola were unremarkable grossly.

Tumor extent

Number: Two ill defined grayish white TBS. 1.5 cm from each other.

Size: 3x1.5x1.5 cm and 3x2x1 cm.

Lymph node involvement: No

Distance from margins: 2 cm from deep margin

Lymph nodes number and size: 8 nodules up to 3 cm.

Additional pathologic findings: N/A

Immunohistochemistry technique: N/A

Frozen section: N/A

Microscopic examination:

Histological type: No remnants of tumor tissue

Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): N/A

Angiolymphatic invasion: Negative

Ductal carcinoma in situ: No

Lymph node involvement: Free axillary lymph nodes (0/8).

Resection Margins: Free

Biologic response to therapy: PCR

Additional pathologic findings: Free nipple.

Diagnosis:

Verified by :

walaa ghoniem

Print Date : 27/03/2024 10:02:58

Page 1 of 2

Printing By : marwa moh

CAP
ACCREDITED

شرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mistr El Qadema - Cairo, Egypt

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



ام هاشم
عبدالله حنفى عوض
قرية سقاره
مركز البدرشين - الجيزة

١٩٨٠/١٠/١٥

٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

KP1536103

٢٠٢٤/٠٦ ٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

ربة منزل

أنثى

متزوجة

مسلمة

رضا محمد ابراهيم ابوشاهين

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/٠٦/١٢

١



Patient's Name:

Umm Hashim Abdullah Hifni Awad

Date:

2026-08-04

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM routine follow up.

Findings:

Right breast

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>> all over area about 116x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
- No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 24/01/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Known case of left breast cancer on therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral 3D MLO DBT (Digital Breast tomosynthesis)
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- Still noted architectural distortion with underlying suspicious pleomorphic microcalcifications.>>> all over area about 116x43mm.

Complementary ultrasound :

- Left UOQ small area of subtle parenchymal distortion measuring about 27x8mm.
 - No right cystic or solid mass lesions.
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
- Bilateral Nonspecific axillary LN.
- Free supra and infra clavicular lymph nodes.

Opinion:

- Left breast UOQ pathologically proven carcinoma showing partial radiological response with underlying suspicious microcalcifications. (BIRADS 6)
- Right breast benign finding (BIRADS2)

Signature Dr. Nehal Hamdy

24/01/2024 2:01 PM

Patient's Name:

Umm Hashim Abdullah Hifni Awad

Date:

2026-08-04

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Right Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Status post left MRM routine follow up.

Findings:

Right breast.

- Scattered fibro-glandular densities. (ACR b)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.
-

Conclusion:-

- *Right breast (BIRADS 1): normal study.*
- *Clear left mastectomy bed and axilla.*

Recommendation:-

- *For annual follow up.*

Best Regards,

DR. Marwa M.Hassan

جمهورية مصر العربية
بطاقة تعقب الشخصية

ام هاشم
عبدالله حفنى عوض
سقاره
مركز البدرشين - الجيزه

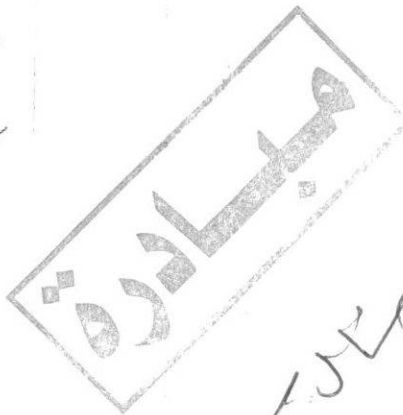
٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

GX2572218



ERM036726187

١٩٧٢
٥٢



٨٤٤٤٤٤٤٤

٢٠١٧/٠٢ ٢٨٠٠٦٠٥٢١٠١١٢٧

رية منزل

أنثى
مسلمة
متزوجة
رضا محمد ابراهيم ابوشاهين

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٤/٠٢/٢٦

٢٠١٥/٢١
٢٠١٥/٢١



Patient Name: Om Hashem Abd Allah Hanafy Awad	Date : 05/05/2025
Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS	Age : 45 Year(s)
Medical ID: 1983/2023	Pat. ID: 43676

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- *enlarged in size (17cm at Rt MCL) homogenous parenchymal echopattern with smooth surface.*
- *No hepatic focal lesions or intra hepatic billiary radicle dilatation.*
- *Portal vein is patent and not dilated.*

Gall Bladder: -

- *Average distention and capacity with no stones or mud*
- *The wall is not thickened.*
- *CBD is not dilated.*

Spleen: -

- *Average size, homogenous.*

Kidneys: -

- *Duplex right kidney with suspected lower malrotated the left kidney is ectopic*
- *Both are average in size, shape and echogenicity*
- *No stones or dilated pelvicalyceal system*
- *No gross lesion*

Para-aortic and pancreatic area: *show no gross abnormalities.*

No ascites

Urinary Bladder: -

- *Average capacity with no stones or diverticular out pouching*

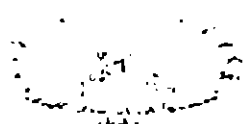
Uterus and adnexal: *no abnormalities could be detected*

Opinion:

Hepatomegaly
Duplex right kidney
Ectopic left kidney
Colonic gaseous distention

Signature Dr . Nermien Ramadan

05/05/2025 2:14 PM



Ministry of Health and Population
Ministry of Health and Population

الوزارة العامة للصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان



MDT form

A-Patient ID:

1- Name: أم هاشم عبدك جنتي نوح

Sex:

3- Medical numbers:

Female

83144545

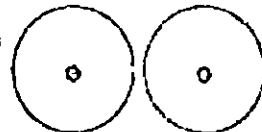
Old Med:

Date of MDT:

1983-2023

2-ID number: 28006052101127

Patient Age: 44 Y



Family history:

Family history:

Phone:

Phone:

01063842427

DHI:

DHI:

REASON OF MDT:

REASON OF MDT:

Marital status:

Marital status:

NRS Score:

NRS Score:

GROUP:

GROUP:

Date of MDT:

Date of MDT:

16/04/2024

Comorbidity:

Comorbidity:

Menopausal status:

Menopausal status:

Initial STAGE:

Initial STAGE:

Clinical data

Breast Imaging:

Mets Workup:

BX:

ER:

PR:

Her 2 Neu:

SISH:

K167:

IDC:

8/B:

8/B:

3:

15:

BX Comment:

ER Comment:

PR Comment:

Her 2 Neu Comment:

SISH Comment:

T:

N:

M:

3:

2:

0:

Sonomammography

LT UOQ MULTIFOCAL MASSES,,AT 20'CLOCK 4.6X2.8CM,,AT 3 O'CLOCK 2.2X2.4CM
MULTIPLE STALITTE 7X6.4MM,,ONE AXILLARY PLNS,,ONE INFRACLAV 9X5MM

PATIENT HISTORY

LAST MDT 23/8/2023-->DUE TO QUERY SLUGGISH RESPONSE FOR NEW BSM

IF RESPONSE CONTINUE THE 4TH CYCLES AC THEN ANOTHER

4 CYCLES TAXOTYERE/HERCEPTIN PERJETA

IF NOT RESPONDING TO SHIFT DIRECTLY TO TAXOTERE/CARBOPLATIN/

HERCEPTIN/PERJETA 4-6 CYCLES.

BSM shows progression so shifted to taxotere / carbo x 7 cycles+ phesgo x 4 cycles with good clinical response

LT MRM:no residual tumor tissue+free nipple , deep margins

free axillary LN 0/8

MDT OUTCOME & PLAN

Complete 17 cycle phesgo ,, PORT,,, 5 YEARS nolvadex then 5 AI + Zoladex.

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

MEDICAL ONCOLOGY

RADIOLOGY

RADIOLOGY

SURGERY

SURGERY

PATHOLOGY

PATHOLOGY

Psychiatric

Psychiatric

Nutrition

Nutrition